



NOTULEN

HARI / TANGGAL : RABU / 15 JANUARI 2025
PUKUL : 09.22 – 13.15 WIB
JENIS MEETING : RAPAT KOORDINASI KLAIM DAN LAPORAN KASUSU IGD
TEMPAT : HALL SAKURA LANTAI 5

Berikut hasil notulen :

No	Penjelasan
1	Pokok Bahasan : Kelengkapan Rekam Medis
	Masalah : Kejelasan Subjektif dan Objektif
	Keterangan :
	PIC :
	1. Kepala Bidang Penunjang Medis 2. Kepala Bidang Pelayanan Medis 3. Rekam Medis 4. IGD
	Rencana Tindak Lanjut 1. Untuk anamnesis lebih diperjelas lagi dengan 5W+1H -> harus ada RPD, RTK dan Riwayat pengobatan → Contoh : a) Pasien DM harus dijelaskan apa sedang on terapi atau tidak on terapi (lihat di I-care atau Vclaim pasien → meminta hak akses ke programmer untuk Icare di ERM IGD) hubungkan dengan rekonsiliasi obat yang ada. b) Hasil pemeriksaan fisik di pertajam dan hasil pemeriksaan penunjang pada pengkajian awal ditulis yang abnormal, supaya bersinergi dengan diagnose yang akan dituliskan, ex: pasien dengan diagnose BP, RR harus sesuai. c) Pada kolom tata laksana harus mencakup therapeutic (medika mentosa) dan/atau prosedur medis (jika ada) 2. 144 diagnostik spesialistik yang dapat ditangani di Faskes 1 bisa beririsan dengan diagnose spesialistik sehingga ada beberapa case yang dapat ditangani di IGD dengan cara mempertajam dari anamnesa dan pemeriksaan fisik sesuai dengan PNPK yang ada. 3. Perbaiki PPK RS dengan minimal 5 diagnosa non bedah (GEA, DF, TF, Pneumonia anak dan dewasa) dan diagnosa bedah (disesuaikan dengan 5 diagnosa tertinggi), dan dokter IGD harus memahami (di buat buku saku) untuk setiap PNPK penyakit yang ada di IGD. 4. Yang berhak memasukkan ke RI adalah dokter IGD, bukan dokter spesialis, dengan melihat PMK 47 tahun 2018 tentang kriteria masuk IGD yang mana kriteria hijau masih abu2 atau bahkan tidak boleh untuk di rawat inapkan di FKTRL → Buat Flyer terkait dengan kriteria P1, P2 dan P3 dan di perjelas jika pasien complain karena tidak di rawat inapkan oleh karena masuk 144 diagnosa yang tidak terindikasi untuk rawat inap di FKTRL maka langsung menghubungi nomor kontak PIC BPJS yang tertera di flyer. 5. Klaim yang akan di ajukan harus melampirkan triage dan pengkajian awal yang sudah terverifikasi dengan benar sesuai dengan kaidah PNPK yang ada, apabila ada pending, boleh dijawab “sudah sesuai dengan PMK 47 tahun 2018 dan sesuai dengan kesepakatan BA BPJS Kesehatan (anamnesa, klinis, penunjang, diagnostic dan terapi harus sesuai dan tergambarkan di E-RM tersebut) 6. Perlu dipertimbangkan untuk membuat form skoring dehidrasi agar memudahkan staf IGD mengisi kriteria di Rekam Medis jika terdapat pasien dengan dehidrasi (dan wajib di tulis berat badan pasien yang real di lembar rekam medis) → memudahkan proses klaim 7. Pada laporan operasi perlu di perjelas alur setiap tindakan yang ada, jangan hanya melampirkan nama tindakan, ex: adelirosis harus di jelaskna bagaimana cara melakukan



	8. Verivikator harus paham dengan apa yang akan di klaim kan mulai dari berkas syarat klaim per masing-masing diagnose → kolaborasi dengan dokter casemix untuk keliling setiap harinya mengontrol berkas yang masih ada di ruangan apakah sudah sesuai mulai dari SPRI hingga resume medis. → ex: pneumonia aspirasi di koding hanya dengan pneumonia → ini akan sangat berbeda dari penunjang dan scor yang akan dilampirkan 9. Membuatkan register khusus pada pasien triage dengan membuatkan alur khusus pasien triage → pasien di daftar BPJS semua dengan di KIE apabila nantinya secara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang tidak di temukan kegawatan maka pasien akan berubah penajmin menjadi pasien umum → tulis di lembar KIE dengan TTD oleh pasien dan keluarga. 10. Terkait dengan penanganan pasien baru datang di IGD tetap dr. IGD wajib melakukan anamnesa se detail mungkin dengan pemeriksaan yang detail → ex: pasien dengan DF mohon jangan hanya melihat demam dan trombosit saja akan tetapi masih banyak kriteria lain sesuai PNPk yang perlu di tanyakan dan di periksa, seperti hematocrit, low intake, penkajian nyeri dengan nilai VAS yang jelas → memperkuat pasien bisa masuk ke rawat inap. 11. Untuk tindakan rawat luka boleh dilampirkan foto lukanya di DRM dan di dokumen klaim sebagai dasar pasien kontrol selanjutnya dengan tetap memperlihatkan identitas pasien di foto tersebut. Dan untuk case rawat luka sebaiknya menggunakan kode diagnose Z.09 (Neoplasma) atau Z.08.0 (non Neoplasma) 12. Untuk diagnosa periodontis kronis (Sp. KGA) diperjelas pada anamnesa dan klinisnya sebagai alasan pasien harus kontrol kembali dengan indikasi tersebut, karena pasien Sp. KGA kunjungan berulang → ex: pada kasus periodontitis kronis harus jelas itu komplek atau simplek, pada kasus gingivitis itu juga harus di pertajam terkait dengan anamnesa dan pemeriksaan. 13. Pada kasus observasi persalinan harus di lampirkan partograph, lembar observasi dan pengkajian awal IGD → buat aturan terkait pada fase mana pasien bisa di terima persalinan di Rumah Sakit apakah pembukaan <4 cm dengan penyulit atau fase aktif → menggunakan coding z.39 atau z.39 O80 & z37 14. Pada kasus Hiperemesis Gravidarum harus diikuti inbalance cairan → jika tidak ditunjang dengan hal tersebut bisa berpotensi pending → gunakan koding O21.1 atau O21.8 15. Ada pemilihan DPJP utama untuk pasien Obygn dengan pasien komplikasi (penyakit kronis) → Mohon cek dan sesuaikan dengan RKK dan SPK yang ada di RS – Contoh : a) Pasien gravida + hipertensi tanpa mengarah ke preeklamsi pasien wajib dirawat oleh IPD b) Pasien Gravida + DM jika kehamilannya stabil maka harus alih rawat IPD c) Pasien DM gestasional cukup konsul ke IPD kemudian tetap dirawat oleh obgyn 16. Ketentuan pengkodean Z48 / Z47 tidak boleh digunakan untuk pengklaiman – CC Asuransi Center 17. Koordinasi dengan DPJP anak yang sering meng MRS kan pasien dari poli ke IGD yang tidak ada kegawatan → lampirkan bukti saat bertemu dengan DPJP 18. Koordinasi dengan setiap FKTP terkait proses merujuk yang tidak sesuai dengan kriteria rujukan
No	Penjelasan
2	Pokok Bahasan : Laporan Kasus
	Masalah : Pasien tidak segera ditangani dengan terapi yang tepat
	Keterangan :
	PIC :
	1. Kepala Bidang 2. DPJP 3. Dokter IGD 4. IGD
	Rencana Tindak Lanjut



	1. Pasien tidak segera ditangani dengan terapi yang tepat sesuai dengan tanda kegawatan → mohon belajar kembali dan lebih berani di sesuaikan dengan RKK dan SPK (kompetensi dokter umum) agar kegawatan pasien tertangani terlebih dahulu 2. Pasien penurunan kesadaran dan meninggal – hasil laboratorium belum jadi – kendala : - IGD tidak menyampaikan ke Unit Laboratorium jika pasien membutuhkan DL CITO - IGD dapat menginput apabila pasien sudah terdaftar → melakukan perubahan alur : a) KARu atau PJ saat itu harus mengontrol apakah tabung sample darah sudah er kirim semua tanpa harus menunggu “barengan” b) Bekerjasama dengan CS jika saat itu IGD Crowded c) Bekerjasama dengan MOD saat di temukan hal tersebut bisa menghubungi CS atau lab untuk turun mengambil. 3. Kendala: a) Pelimpahan tanggungjawab pasien dari shift satu ke berikutnya ada beberapa dokter yang tidak maksimal karena lebih fokus ke pasiennya sendiri b) Keterbatasan HCU Isolasi c) Ada beberapa dokter IGD masih ragu dalam memberikan terapi awal karena takut disalahkan DPJP karena salah terapi d) IGD terkoneksi pada unit Laboratorium sehingga harus konfirmasi pada Laboratorium jika ada penginputan -- tidak bisa cetak pengantar laboratorium 4. Rencana Tindak Lanjut : a) Jika ada pasien yang datang pada jam operan shift, maka yang bertanggungjawab adalah kedua dokter tersebut di shift sebelum dan setelahnya → sehingga dokter IGD yang bertugas di shift selanjutnya harus menyelesaikan pasien tersebut sampai selesai b) Jika ada pasien yang membutuhkan HCU Isolasi bisa memakai ruang HCU Reguler – koordinasi dengan PPI untuk pensterilan UV setelah ruangan itu dipakai c) Pasien yang masih abu-abu (masih belum jelas dirawat oleh Dokter Spesialis – dokter IGD berhak menentukan dan memberikan terapi awal kegawatdaruratan karena itu termasuk dari SPK dan RKK dokter IGD) -- Dokter IGD dan DPJP adalah partner, tidak ada saling menyalahkan sehingga jalin komunikasi dengan baik antara IGD dan DPJP Saran : Setiap konsul melalui <i>Whatsapp</i>, selalu memperkenalkan nama dokter IGD dengan jelas d) Koordinasi dengan IT untuk bisa dikoneksikan
--	--

Pemimpin Rapat
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah

Malang, 15 Januari 2025
Notulis

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Maheza Yudistirant, S.AP

DOKUMENTASI

